

1. Introducción y relevancia clínica

La **adenoiditis crónica** corresponde a la **inflamación persistente e hipertrófica del tejido adenoideo (amígdala faríngea)**, localizado en la pared posterior del **rinofaringe**. Es una **causa muy frecuente de obstrucción nasal crónica en la infancia**, y contribuye a **otitis media serosa, sinusitis recurrente y trastornos del sueño**.

Su reconocimiento es crucial, ya que:

- Constituye una **causa corregible de respirador bucal crónico**.
- Afecta el **desarrollo craneofacial, el sueño, el rendimiento escolar y la audición**.
- Es una **patología de alta prevalencia** en el grupo preescolar (2–8 años).
- Es indicación frecuente de **adenoidectomía**, sola o asociada a **amigdalectomía o colocación de tubos de ventilación**.

Relevancia en EUNACOM

- Pregunta típica de semiología pediátrica ORL.
 - Debe reconocerse el **cuadro clínico típico de respirador bucal con voz nasal, ronquido y otitis recurrente**.
 - Conocer **cuándo derivar a ORL y las indicaciones quirúrgicas**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

Las **adenoides** forman parte del **anillo linfático de Waldeyer**, junto con las amígdalas palatinas y linguales.

Su función es inmunológica: captar antígenos inhalados o ingeridos, especialmente durante la infancia.

2.2 Hiperplasia e inflamación crónica

- En niños, la estimulación antigénica repetida (virus respiratorios, bacterias) causa **hiperplasia linfática**.
- Cuando el estímulo persiste (alergias, infecciones frecuentes), se produce **adenoiditis crónica**, con:
 - Edema de mucosa.
 - Colonización bacteriana persistente (biofilm).
 - Obstrucción mecánica de coanas y trompas de Eustaquio.

2.3 Bacteriología típica

- **Streptococcus pneumoniae**
- **Haemophilus influenzae** (no tipificable)
- **Moraxella catarrhalis**
- **Staphylococcus aureus** (en casos resistentes)
- **Anaerobios** en infecciones prolongadas.

Estos microorganismos pueden actuar formando **biofilms**, que dificultan la erradicación con antibióticos.

2.4 Fisiopatología de la obstrucción nasofaríngea

La **masa adenoidea hipertrófica** obstruye parcialmente las **coanas** → respiración bucal y ronquido.

Además, al comprimir el **orificio tubárico**, altera la **ventilación del oído medio**, favoreciendo **otitis media serosa o recurrente**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

- **Obstrucción nasal crónica** (respiración bucal).
- **Ronquido habitual nocturno**, voz nasal ("hiponasal"), sueño inquieto.

- **Rinorrea crónica mucopurulenta**, especialmente posterior (“goteo retronasal”).
- **Tos nocturna persistente** (por secreción retronasal).
- **Otitis media serosa o recurrente** (por obstrucción tubárica).
- **Halitosis, apneas del sueño, disfagia ocasional.**

3.2 Signos característicos

- **Facies adenoidea:**
 - Boca entreabierta.
 - Labio superior corto.
 - Ojeras (“sombras infraorbitarias”).
 - Nariz estrecha y puente nasal elevado.
- **Voz hiponasal** (resonancia nasal disminuida).
- **Amígdalas palatinas normales o hipertrofiadas** (asociación frecuente).
- **Rinorrea persistente posterior.**

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características diferenciales
Rinitis alérgica	Prurito nasal, estornudos, mucosa pálida; respuesta a antihistamínicos.
Sinusitis crónica	Cefalea, halitosis, rinorrea purulenta frontal o maxilar.
Desviación septal / pólipos	Poco común en niños, hallazgos nasales claros.

Adenoiditis aguda Fiebre, odinofagia, dolor retrofaríngeo agudo.

Hipertrofia amigdalar aislada Obstrucción orofaríngea, sin rinorrea retronasal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

Principalmente **clínico**, basado en:

- Historia de **obstrucción nasal crónica, ronquido habitual, respiración bucal y rinorrea persistente.**
- Antecedentes de **otitis media serosa/recurrente.**

4.2 Exámenes de apoyo

Examen	Utilidad
Nasofibroscopía flexible	Gold standard: visualiza tamaño adenoideo y grado de obstrucción coanal (<25%, 25–50%, >75%).
Radiografía lateral de cavum	Alternativa si no hay fibroscopio; evalúa hipertrofia adenoidea (relación adenoide/nasofaringe >0,7 sugiere obstrucción significativa).
Timpanometría	Detecta disfunción tubárica u otitis serosa asociada (curva tipo B o C).
Audiometría	Si hay sospecha de hipoacusia.

Diagnóstico confirmado: clínica compatible + evidencia de hipertrofia adenoidea obstructiva (nasofibroscopía o radiografía lateral).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivos

- Mejorar la permeabilidad nasal y ventilación del oído medio.
- Controlar la infección y reducir la inflamación.
- Prevenir complicaciones (otitis, apnea del sueño, alteraciones del lenguaje).

5.2 Tratamiento médico inicial

En cuadros leves o como manejo inicial antes de derivación:

1. **Lavados nasales con suero fisiológico** (3–4 veces al día).
2. **Corticoides tópicos nasales** (fluticasona, mometasona) por 4–8 semanas:
 - Disminuyen la inflamación y volumen adenoideo.
 - Mejoran la respiración y el ronquido.
3. **Antibióticos:**
 - Solo si hay secreción purulenta o infección asociada (p. ej., amoxicilina/ácido clavulánico 10–14 días).
 - Evitar cursos prolongados repetidos (resistencia).
4. **Tratamiento de rinitis alérgica** si coexiste: antihistamínicos, control ambiental.
5. **Evitar irritantes ambientales** (tabaco, polvo, aerosoles).

5.3 Indicación de adenoidectomía

Criterios quirúrgicos (MINSAL y SOCHIORL):

Indicaciones absolutas	Indicaciones relativas
Obstrucción nasal severa persistente (>3 meses) con respiración bucal y ronquido habitual	OMA/OME recurrente asociada a hipertrofia adenoidea
Apnea del sueño documentada o sospechada (ronquido + pausas respiratorias)	Hiponasalidad persistente y tos retronasal crónica
Fallo de tratamiento médico óptimo (≥2 meses)	Compromiso de desarrollo craneofacial / dental ("facies adenoidea")
Retraso del lenguaje o hipoacusia secundaria a OME	Necesidad de tubos transtimpánicos repetidos

Técnica quirúrgica:

- **Adenoidectomía por curetaje o aspiración endoscópica.**
- Generalmente ambulatoria.
- En muchos casos se asocia a **amigdalectomía o colocación de tubos transtimpánicos.**

5.4 Cuidados postoperatorios

- Control del dolor con paracetamol o ibuprofeno.
 - Evitar esfuerzos, alimentos duros o irritantes por 5–7 días.
 - Control ORL a las 2–3 semanas.
 - El ronquido puede persistir transitoriamente por edema.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones de la adenoiditis crónica (sin tratamiento)

- Otitis media serosa o recurrente.
- Apnea del sueño / hipoventilación nocturna.
- Trastornos del crecimiento craneofacial (“facies adenoidea”).
- Rinorrea crónica, tos retronasal, sinusitis crónica.
- Trastornos de lenguaje y atención secundarios a hipoacusia.

6.2 Complicaciones postquirúrgicas (raras)

- Hemorragia postoperatoria (<1%).
- Insuficiencia velofaríngea transitoria (hipernasalidad).
- Recrecimiento adenoideo (5–10%, más en <4 años o alergias persistentes).

6.3 Pronóstico

Excelente:

- La mayoría mejora la respiración nasal, el sueño y la audición.
- El rendimiento escolar y el lenguaje se normalizan tras la cirugía.
- Recidivas son raras si se asocian medidas antialérgicas y control ambiental.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas clínicas

1. **Adenoiditis crónica = obstrucción nasal + respiración bucal + ronquido + rinorrea retronasal.**
2. **Tos nocturna crónica sin asma** en niños suele deberse a **secreción retronasal adenoidea.**

3. **Otitis media serosa** frecuente → pensar en **hipertrofia adenoidea obstructiva**.
 4. **Radiografía lateral de cavum** es útil en APS si no se dispone de nasofibroscopía.
 5. **Corticoides tópicos nasales** reducen síntomas y tamaño adenoideo en cuadros leves.
 6. **Adenoidectomía** indicada ante obstrucción severa, apnea, OME persistente o fracaso médico.
 7. **Asociación quirúrgica** más frecuente: **adenoidectomía + colocación de tubos de ventilación**.
-

✗ Errores comunes

- Confundir **rinitis alérgica crónica** con adenoiditis sin exploración adecuada.
 - No tratar **rinitis alérgica asociada**, lo que causa **recrecimiento postoperatorio**.
 - Indicar antibióticos de forma repetida y prolongada sin evaluación ORL.
 - No reconocer la **relación entre OME persistente e hipertrofia adenoidea**.
 - Subestimar la **repercusión del sueño** y la **fatiga diurna** en estos niños.
 - Pensar que la adenoidectomía es un “procedimiento menor sin indicaciones precisas” (error conceptual).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **adenoiditis crónica** es una inflamación persistente de la amígdala faríngea, frecuente entre 2–8 años.
2. Se manifiesta con **obstrucción nasal crónica, respiración bucal, ronquido habitual, voz hiponasal y rinorrea retronasal**.
3. Su diagnóstico es **clínico** y se confirma por **nasofibroscopía o radiografía lateral de cavum**.

4. El **manejo inicial** incluye lavados nasales, **corticoides tópicos**, tratamiento de alergia y control ambiental.
5. La **adenoidectomía** está indicada ante obstrucción severa, apnea del sueño, OME persistente o fracaso médico.
6. Suele asociarse a **otitis media serosa** y mejora significativamente la ventilación y el lenguaje tras cirugía.
7. El **pronóstico es excelente**, con bajo riesgo de recidiva si se controlan factores predisponentes.